

# Modelo cognitivo: conceptos fundamentales

*Referencia teorica para el terapeuta TCC*

## PREMISA CENTRAL

*"No son los eventos los que perturban a los hombres, sino las opiniones sobre los eventos."*

## Pensamientos automaticos

Cogniciones rapidas, espontaneas y breves que surgen ante situaciones. No son elegidos. En el momento se perciben como verdaderos. Afectan directamente las emociones y las conductas.

**Forma:** Verbal o imagenes

**Caracter:** Habitualmente negativos en el malestar psicologico

**Evaluacion:**  
Pueden ser realistas, distorsionados o una mezcla

## Creencias intermedias

Actitudes, reglas y supuestos condicionales que median entre las creencias nucleares y los pensamientos automaticos. Mas especificas que las nucleares, mas estables que los automaticos.

**Actitudes:** 'Los errores son inaceptables'

**Reglas:** 'Debo trabajar al maximo siempre'

**Supuestos:** 'Si no lo hago bien, soy un fracaso'

## Creencias nucleares

Ideas absolutas y globales sobre uno mismo, los demas y el mundo. Se forman en la infancia. Son el nivel mas profundo del modelo. Resistentes al cambio. Activan esquemas.

**Sobre el self:**  
Incompetencia, no ser querido, ser diferente

**Sobre otros:**  
Peligro, abandono, desconfianza

**Sobre el mundo:**  
Peligro, injusticia, impredecible.

## Distorsiones cognitivas

Errores sistematicos en el procesamiento de la informacion que mantienen las creencias negativas a pesar de la evidencia contraria.

**Tipos frecuentes:** Todo-o-nada, catastrofismo, filtro negativo, lectura mental **Intervencion:** Identificar, nombrar, generar alternativas

● Clave clinica: el modelo cognitivo es jerarquico pero no rigido. En la practica clinica los niveles se retroalimentan. La direccion del trabajo depende del estadio del tratamiento.